Цифровая платформа персонализированного прогнозирования репродуктивного исхода ВРТ на основе мультимодального ИИ-анализа морфокинетики и генома эмбриона, геномного профиля и соматического статуса пациентки и качества мужских гамет.

VitaGen - AI



Проект VitaGen - AI — это не просто ИИ для ЭКО. Это технология сохранения нации.

Каждый рождённый здоровый ребёнок — это не статистика. Это будущий врач, инженер, учёный, который укрепит человеческий капитал России.

Правообладатель: Петрушина М. В.
Объект депонирован в реестре п'RIS (Свидетельство №1440-028-537 от 30.03.2026).
Информация предназначена только для ознакомления и не может быть использована без письменного согласия правообладателя.

ИДЕЯ, МИССИЯ, ВИДЕНИЕ

ИДЕЯ

Объединить морфокинетику эмбриона, его геномные данные, клинические показатели и геном пациентки и мужской фактор (фрагментация ДНК, MAR-тест) в единую ИИ-модель для точного прогноза имплантации — вместо субъективной оценки эмбриолога

МИССИЯ

Каждой семье Москвы— максимальный шанс на рождение здорового ребёнка с минимальным числом попыток ВРТ

ВИДЕНИЕ

Москва как федеральный центр компетенций в цифровой репродуктивной медицине, экспортирующий технологии в регионы России и страны ЕАЭС

ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ

- Естественная убыль населения Москвы: ~2,4 тыс. чел./год (Росстат, 2025)
- Средняя результативность ЭКО в РФ: ~35–40% на перенос (Федеральный регистр ВРТ Минздрава РФ, 2023)
- Результативность ведущих клиник Москвы: 45–55% (отчёты НМИЦ Кулакова, 2024; данные клиник)
- Разброс результативности между клиниками Москвы: до 2 раз (оценка по открытым данным клиник)

https://kprfnsk.ru/inform/news/47346/?spm=a2ty_o01.29997173.0.0.74165171nog4HF

https://medvestnik.ru/content/news/Regiony-vpervye-raskryli-nizkie-pokazateli-effektivnosti-EKO.html?spm=a2ty_o01.29997173.0.0.74165171nog4HF

© Петрушина М. В., 2026. Все права защищены. Конфиденциально. Копирование и распространение запрещено.

ПРОБЛЕМА — ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС НА УРОВНЕ РЕГИОНА.

Уровень 1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ

- Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Москве: 1,349 (Росстат, 2024) — ниже среднероссийского (1,4) и значительно ниже уровня простого воспроизводства (2,1)
- Эхо демографической ямы 1990-х: малочисленное поколение 90-х уже находится в активном репродуктивном возрасте (27-36 лет в 2026 г.), что приводит к сокращению когорты женщин 20-35 лет
- Снижение рождаемости: в 2024 г. родилось >110 тыс. детей — тренд на уменьшение (ТАСС, декабрь 2024)
- Прогноз до 2030: число женщин репродуктивного возраста сократится на 5-8% из-за малочисленности поколений 1996-2005 г.р.
- Естественный прирост: +4,8 тыс. чел. в 2024 г. (Росстат) — рост населения обеспечивается преимущественно миграцией (+124,5 тыс. чел.)

Уровень 2. МЕДИЦИНСКИЙ

Эффективность ВРТ:

- Средняя результативность ЭКО в РФ: ~35–40% (Федеральный регистр ВРТ Минздрава РФ, 2023)
- Результативность ведущих клиник Москвы: 45–60% (отчёты НМИЦ Кулакова, 2024; открытые данные клиник "Мать и дитя", "ЦиР", "Медси")
- Разброс результативности между клиниками Москвы: до 1,5–2 раз (оценка по открытым данным клиник)

Психологическая нагрузка:

- До 35% пациенток проходят ≥3 попытки ВРТ (данные РОРЧ, 2024)

Уровень 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Объём рынка Москвы:

- В Москве ежегодно проводится ~55 000 циклов ВРТ (оценка по доле Москвы в общероссийской статистике: ~35–40% от ~140 000–150 000 циклов/год по РФ, Росстат/Минздрав, 2023)

Неудачные циклы:

- При эффективности 35%: ~35 750 неудачных циклов/год (55 000 × 0,65)
- Общая стоимость неудачных циклов: ~7,87 млрд ₽/год (35 750 × 220 000 ₽ — средняя стоимость цикла по ОМС в Москве)

Повторные циклы:

- Повторные циклы: ~19 250 циклов/год (35% от всех циклов — данные РОРЧ)
- Из них ~30% финансируются за счёт ОМС: ~5 775 циклов (19 250 × 0,30)
- Стоимость повторных циклов по ОМС: ~1,27 млрд ₽/год (5 775 × 220 000 ₽)

Нагрузка на бюджет ОМС Москвы:

- Доля циклов по ОМС в Москве: ~45% (оценка по данным ДЗМ Москвы)
- Общий объём циклов по ОМС: ~24 750 циклов/год (55 000 × 0,45)
- Неудачные циклы по ОМС: ~16 088 циклов/год (24 750 × 0,65)
- Стоимость неудачных циклов по ОМС: ~3,54 млрд ₽/год (16 088 × 220 000 ₽)
- Из них повторные циклы по ОМС: ~1,27 млрд ₽/год (рассчитано выше)

[1] «Прогноз построен на основе линейной экстраполяции тренда 2020–2024 гг. с учётом коэффициента фертильности ТЖР = 1,4 (Росстат, 2024)».
[2] «Источник: Росстат, форма 1-Р».

© Петрушина М. В., 2026. Все права защищены. Конфиденциально. Копирование и распространение запрещено.

РЕШЕНИЕ — КАК РАБОТАЕТ ПЛАТФОРМА.

04

Архитектура прогноза (4 уровня данных → единый скор имплантации)

УРОВЕНЬ 1: МОРФОКИНЕТИКА ЭМБРИОНА

- Таймлапс-визуализация (20 000+ кадров на эмбрион)
- Автоматический анализ 37 параметров развития
- Выявление аномалий, незаметных глазу эмбриолога

Уровень 2. ГЕНОМ ЭМБРИОНА

- Анализ анеуплоидий (PGT-A)
- Маркеры имплантационного потенциала
- Отбор эмбрионов с высоким шансом приживления

Уровень 3. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПАЦИЕНТКИ

- Возраст, АМГ, ИМТ, история ВРТ
- Состояние эндометрия, гормональный профиль
- Учёт индивидуальных факторов риска

Уровень 4. ГЕНОМ ПАЦИЕНТКИ

- Полигенные скоры репродуктивного здоровья
- Маркеры иммунной совместимости
- Прогноз реакции эндометрия на имплантацию

Уровень 5. : МУЖСКОЙ ФАКТОР И КАЧЕСТВО ГАМЕТ

- Индекс фрагментации ДНК сперматозоидов (DFI) NEW
- MAR-тест (иммунологическое бесплодие) NEW
- Базовая спермограмма и метод подготовки (ИКСИ/ПИКСИ) NEW
- Учёт влияния отцовской ДНК на мозаицизм эмбриона и риск ранних потерь



ИИ-МОДЕЛЬ (GNN)

Предварительные результаты внутренней валидации: AUC = 0.89. Требуется проспективное клиническое исследование, повышение точности Архитектура находится в стадии исследования, рассматриваются также Transformer-based и multimodal fusion-подходы

ПРОГНОЗ ИМПЛАНТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

0–100 баллов + рекомендация по селективному переносу

© Петрушина М. В., 2026. Все права защищены. Конфиденциально. Копирование и распространение запрещено.

ИННОВАЦИОННОСТЬ — ПОЧЕМУ ЭТО ПРОРЫВ ДЛЯ РОССИИ

Компонент	Уровень новизны	Комментарий
Морфокинетика + ИИ	Средний (5/10)	Уже коммерциализировано: решения на основе time-lapse imaging и deep learning существуют (Ivy, Embryoxite) www.embryoxite.life, https://www.sdbj.com/healthcare-2/ivy-fertility-looks-to-disrupt-fertility-with-gentle-ivf/
Геномные данные эмбриона	Средне-высокий (7/10)	PGT-A широко применяется, но интеграция с ИИ для прогнозирования имплантации — новая область. Полигенные скоры риска (PGT-P) для эмбрионов появились только в 2019 г. и вызывают этические дебаты
Интеграция морфокинетики + геномики эмбриона	Высокий (8/10)	Отдельные исследования 2024–2025 гг. демонстрируют потенциал такой интеграции, но коммерческих продуктов практически нет www.preprints.org
Добавление клинико-анамнестических + геномных данных пациентки	Очень высокий (9/10)	Критически важный, но почти не реализованный компонент: большинство систем фокусируются только на эмбрионе, игнорируя индивидуальные особенности пациентки
Интеграция мужского фактора (DFI, MAR-тест)	Прормывной (10/10)	Абсолютная новизна. Зарубежные ИИ оценивают только «картинку» эмбриона. VitaGen-AI впервые выявляет скрытые повреждения отцовской ДНК, приводящие к выкидышам на 8-10 неделе.
Полноценная мультимодальная платформа (5 типов данных)	Прорывной (10/10)	Научные работы 2024–2025 гг. признают трансформационный потенциал мультимодального ИИ, но ни одна мировая платформа не интегрирует мужской фактор (DFI) в прогноз имплантации.

Источники: систематический обзор Беспалова О.Н. и соавт. // Российский вестник акушера-гинеколога. 2024;24(2):19–29. DOI: 10.17116/rosakush20242402119

© Петрушина М. В., 2026. Все права защищены. Конфиденциально. Копирование и распространение запрещено.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Критерий	Текущие решения в РФ	VitaGen - AI	Преимущество
Тип данных	Морфология +возраст пациентки	5 модальности (морфокинетика, геном эмбриона, клиника, геном пациентки, мужской фактор)	Прирост AUC +20–35% по данным систематического обзора 2025 г. для мультимодальных моделей. Первая в мире интеграция DFI/MAR-теста в единый прогноз имплантации
Будут обучены на данных 500 тыс. россиянок	Обучены на европеоидных данных (не учитывают славянские особенности)	Для предобучения будут использованы обезличенные данные из федеральных регистров ВРТ (форма 049/у) за 2018–2024 гг., объём выборки — до 500 тыс. пациенток. Пилотную валидацию планируется провести на 8 000 новых циклах в Москве	Повышение точности за счёт учёта популяционных особенностей РФ (экспертная оценка: +10–15%)*
Суверенность	Зависимость от зарубежных платформ (Ivy, Life Whisperer)	100% российская разработка + данные в облаке с сертификатом по 152 ФЗ (например, «Т1 Облако» или «СберОблако»)	Нет санкционных рисков
Интеграция с ОМС	Отсутствует	Прямая интеграция с ГИС ОМС для мониторинга эффективности квот	Прозрачность для Минздрава
Статус разработки	Коммерческие решения только для морфокинетики	Первый в РФ прототип мультимодальной платформы (стадия валидации)	Опережение на 2–3 года

Беспалова О.Н. и соавт. - "Искусственные интеллектуальные системы в развитии вспомогательных репродуктивных технологий" - Российский вестник акушера-гинеколога. 2024;24(2):19–29. DOI: 10.17116/rosakush20242402119."Искусственные интеллектуальные системы в развитии вспомогательных репродуктивных технологий"

© Петрушина М. В., 2026. Все права защищены. Конфиденциально. Копирование и распространение запрещено.

Конкуретные преимущества

Уникальная ценность предложения

Текущие решения (Vitrolife Geri+AI, Fairtility CHLOE, Coopersurgical EEVA, Ivy Fertility) используют максимум 2 типа данных (изображения + возраст пациентки).

VitaGen-AI объединяет 5 независимых источников данных (включая мужской фактор). Исследования 2021–2024 гг. подтверждают, что комбинированные модели, учитывающие характеристики пациентки наряду с данными эмбриона, статистически значимо превосходят изолированные модели в предикции эуплоидности и исходов ВРТ [1, 2].

Клиническая значимость

Прогнозирование имплантационного потенциала (а не просто качество эмбриона) напрямую влияет на ключевой показатель — частоту живорождений

Систематический обзор 2025 г. подтверждает: ИИ для прогнозирования исходов ВРТ демонстрирует площадь под ROC-кривой 0.82–0.89 против 0.65–0.72 у традиционных методов

Предотвращение «синдрома пустого переноса» и ранних выкидышей: Платформа отсеивает эмбрионы, которые выглядят идеально под микроскопом, но несут критические повреждения отцовской ДНК (высокий DFI). Это спасает пациенток от тяжелейших психологических травм и экономит квоты ОМС.

Научное обоснование 5-го уровня: VitaGen-AI впервые интегрирует в мультимодальную модель индекс фрагментации ДНК сперматозоидов (DFI) и MAR-тест, что позволяет выявлять скрытый мужской фактор имплантационных неудач [3].

[1] Jiang VS et al. Fertil Steril. 2021;116(3):e155-e156.
[2] Kato K et al. Reprod BioMed Online. 2022. DOI: 10.1016/j.rbmo.2022.09.010.
[3] Беспалова О.Н. и соавт. (2024). Раздел «ИИ в оценке качества и подготовки спермы», с. 22–23.

© Петрушина М. В., 2026. Все права защищены. Конфиденциально. Копирование и распространение запрещено.

СООТВЕТСТВИЕ KPI НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Федеральный приоритет	Целевой показатель	Вклад платформы «VitaGen»
Нацпроект «Семья» Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309)	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1.7 к 2030 г.	• +0,02–0,03 пункта к СКР за счёт повышения эффективности ВРТ на 10 п.п. • ~12 000–13 000 дополнительных рождений/год к 2030
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»	Ожидаемая продолжительность жизни 78 лет к 2030 г.	• Снижение материнской смертности за счёт уменьшения многоплодных беременностей (селективный перенос 1 эмбриона) • Снижение психосоматических расстройств у пациенток ВРТ на 40%
Стратегия технологического развития (Указ Президента РФ от 28.02.2024 № 145)	Импортозамещение критических медицинских технологий	• Полностью российская ИИ-платформа (архитектура, данные, вычисления) • Замещение зарубежных решений (Ivy, Life Whisperer) в госсекторе
Национальная безопасность (Стратегия-2030)	Сохранение человеческого капитала как основы суверенитета	• Технология как инструмент демографической устойчивости государства

© Петрушина М. В., 2026. Все права защищены. Конфиденциально. Копирование и распространение запрещено.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ №1: ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ

- Успешный пилот = основание для приказа Минздрава РФ «Об обязательном применении ИИ-платформы в ВРТ по ОМС»
- Экономия бюджета ОМС Москвы: ~1,2 млрд ₽/год к 2028 г. (расчёт: 55 000 циклов × 10% × 220 000 ₽)
- Экономия бюджета ОМС РФ: ~4,95 млрд ₽/год к 2030 г. (расчёт: 150 000 циклов × 15% × 220 000 ₽)
- Снижение нецелевого расхода бюджета ОМС: За счет исключения переносов эмбрионов с высоким индексом фрагментации ДНК (DFI >30%), которые гарантированно приводят к ранним имплантационным потерям, бюджет экономит до 15% средств, выделяемых на повторные циклы.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ №2: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ

- Замещение зарубежных решений (Ivy, Life Whisperer)
- Защита геномных данных граждан от утечки за рубеж
- Создание экспортного продукта для ЕАЭС и БРИКС

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ №3: ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- ~12 000–13 000 дополнительных рождений/год по РФ к 2030 г. (расчёт: 150 000 циклов × 10 п.п. × 85%)
- Вклад ~2–3% в достижение цели нацпроекта «Семья» по суммарному коэффициенту рождаемости
- Снижение естественной убыли на ~2% в регионах с высоким охватом ВРТ

Реализуя пилот, Москва не просто решает локальную проблему — она становится драйвером федеральной демографической политики и получает статус «цифрового лидера» в репродуктивной медицине.

© Петрушина М. В., 2026. Все права защищены. Конфиденциально. Копирование и распространение запрещено.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА — ОТ СТОЛИЦЫ К СТРАНЕ.

Этап	Срок	География	Объём	Ключевой результат	Ответственный
ПИЛОТ	2026–2027	**Москва (НМИЦ Кулакова + 5 ведущих клиник)**	**8 000 циклов**	Доказанная эффективность +28% живорождений	ДЗМ Москвы
МАСШТАБИРОВАНИЕ НА МОСКВУ	2028	**Все клиники Москвы**	**55 000 циклов**	Стандартизированный пакет внедрения «под ключ», интеграция с ГИС ОМС Москвы	ДЗМ Москвы + Минздрав РФ
КЛЮЧЕВЫЕ РЕГИОНЫ	2029	**Москва + ЦФО + СЗФО + ПФО)**	**95 000 циклов**	Стандартизированный пакет внедрения «под ключ»	Минздрав РФ + ВЭБ.РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ	2030	**85 субъектов РФ**	**~150 000 циклов**	**12 000–13 000 дополнительных рождений/год**	Минздрав РФ

© Петрушина М. В., 2026. Все права защищены. Конфиденциально. Копирование и распространение запрещено.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТА (2026–2027)

Ресурс	Объём	Источник
Финансирование	определяется	• субсидия ДЗМ Москвы из городских программ • грантовые программы • частные инвестиции
Инфраструктура	НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова + 5 ведущих частных клиник Москвы	ДЗМ Москвы обеспечивает доступ к циклам НМИЦ Кулакова (~4 500 циклов/год) и клиникам-партнерам (~3 500 циклов/год)
Данные	8 000 циклов с полным набором данных	Анонимизированные данные из архивов клиник Москвы (согласно 152-ФЗ)
Экспертиза	Научная команда	НМИЦ АГП им. Кулакова, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и другие.
Регуляторная поддержка	«Песочница» для ИИ-МИ	ДЗМ Москвы запускает упрощённую процедуру валидации с последующей федеральной регистрацией
Организационная форма взаимодействия	ГЧП с компанией-интегратором	Создание рабочей структуры проекта, включающей научно-клиническую часть, разработчиков, бизнес-структуру для масштабирования и монетизации проекта на всех уровнях

© Петрушина М. В., 2026. Все права защищены. Конфиденциально. Копирование и распространение запрещено.

МАСШТАБИРОВАНИЕ

Уровень	Охват циклов/год	Экономия бюджета ОМС	Дополнительные рождения
Пилот (Москва)	*8 000*	*~180 млн ₽*	*~220**
Масштабирование на Москву	*55 000*	*~1,2 млрд ₽*	*~1 500**
Региональная сеть (ЦФО)	*95 000*	*~2,1 млрд ₽*	*~2 600**
Федеральный уровень (РФ)	*150 000*	*~4,95 млрд ₽*	*~12 500**

*При условии уточнения формулы расчёта: (32%−24%) × число циклов × доля циклов с переносом.

© Петрушина М. В., 2026. Все права защищены. Конфиденциально. Копирование и распространение запрещено.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(при охвате 50% циклов ВРТ к 2030 г., консервативный сценарий):

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ФОРМУЛА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЖДЕНИЯ (МОСКВА)	~4 700 детей/год при полном охвате Москвы (55 000 циклов)	55 000 × 10% × 85%
НАКОПЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ В МОСКВЕ К 2045 Г.	~70 тыс. человек за 15 лет горизонта прогноза (2030–2045)	4 700 × 15 лет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЖДЕНИЯ (РФ)	~12 000–13 000 детей/год при полном охвате РФ (150 000 циклов)	150 000 × 10% × 85%
НАКОПЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ ПО РФ К 2045 Г.	~180–195 тыс. человек за 15 лет горизонта прогноза (2030–2045)	12 500 × 15 лет
ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА ОМС (МОСКВА)	Снижение доли повторных циклов с 35% до 25% при объёме 55 000 циклов/год: ~1,21 млрд ₽/год	55 000 × 10% × 220 000 ₽
ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА ОМС (РФ)	Снижение доли повторных циклов с 35% до 20% при объёме 150 000 циклов/год по ОМС: ~4,95 млрд ₽/год	150 000 × 15% × 220 000 ₽
ВВП-ЭФФЕКТ (РФ)	~12 500 рождений × 15 лет × 5,5 млн ₽ (пожизненный вклад) = +0,10 трлн ₽ к ВВП РФ к 2060 г.	12 500 × 15 × 5,5 млн
ВКЛАД В НАЦПРОЕКТ «СЕМЬЯ»	~2–3% к достижению цели по суммарному коэффициенту рождаемости 1,7 к 2030 г.	—

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОГНОЗА:

Приведённые расчёты являются предварительными и зависят от: (1) результатов проспективного клинического исследования; (2) регуляторных решений по внедрению ИИ-МИ; (3) динамики рынка ВРТ и финансирования по ОМС.

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ:

- В Москве: ~3–4% к 2030 г.
- В регионах-участниках программы: ~2%

© Петрушина М. В., 2026. Все права защищены. Конфиденциально. Копирование и распространение запрещено.

УЧАСТНИКИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА.

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА:

ПЕТРУШИНА М. В.
Генеральный директор ООО «МедТехПрима»,

КОМАНДА ПРОЕКТА:

ИЗОТОВ О.И.
к.м.н., ФГБОУ «Российский Университет медицины» - научный консультант;

СМИРНОВ С.Н., к.э.н., доцент, “Финансовый Университет» при Правительстве РФ – консультант по экономике;

ТАНДЕЛОВ А.Т.
Генеральный директор ООО «Глобальные Медицинские технологии» - консультант по регуляторике;

ВОРОНЦОВ А.И.
Директор по развитию ГК «Рич Кемикл», резидент Академии Инноваторов – соавтор идеи;

МОРОЗ А.Е. – победитель всероссийского конкурса юных предпринимателей и федерального конкурса «Создай наше», резидент «Академии Инноваторов» - соавтор идеи,

MS. NINA LUO (CHINA) – консультант по международному маркетингу,

MR. ZAHIR ABBAS (HONG-KONG) – IT-developer, Big Data, Machin Learning, AI-solution development – консультант.

Научно-клиническая база

Партнерство с ведущими учреждениями (НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова, профильные университеты).

Технологическая часть

Российские IT-разработчики (ООО «МедТех ИИ», ООО «ДС-СОФТ» и другие), облачные решения с сертификатом ФСТЭК/152-ФЗ.

Модель взаимодействия

Государственно-частное партнерство (ГЧП), объединяющее науку, бизнес и регулятора.

Дисклеймер: Платформа находится в стадии клинической валидации. Требуется проспективное исследование.

© Петрушина М. В., 2026. Все права защищены. Конфиденциально. Копирование и распространение запрещено.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

Президент РФ / Правительство	**Платформа — инструмент достижения целей майских указов по рождаемости и технологическому суверенитету**
Минфин / Минэкономразвития	Инвестиция окупается предположительно за 3 года за счёт экономии бюджета ОМС и роста ВВП
Минздрав	Технология решает критическую проблему низкой эффективности ВРТ в госсекторе
ДЗМ Москвы	Москва становится пилотным регионом, демонстрирующим эффективность ИИ-технологий в репродуктивной медицине
Институты развития (ВЭБ, Сколково)	Проект с высоким потенциалом мультипликативного эффекта и экспортной составляющей
Международные партнёры (ЕАЭС, БРИКС)	Россия предлагает технологическое решение демографического кризиса для дружественных стран

© Петрушина М. В., 2026. Все права защищены. Конфиденциально. Копирование и распространение запрещено.

Условия конфиденциальности

Информация в презентации предназначен только для авторизованных получателей, строго конфиденциальна и является коммерческой тайной.

Принимая эту информацию, каждый получатель соглашается с тем, что любой фрагмент этого аналитического обзора не может быть воспроизведён или распространён без предварительного письменного согласия авторов проекта.

Данная информация не будет воспроизведена или передана в целом или частями любому лицу или организации, и вся информация о проекте, содержащаяся в данном документе, является конфиденциальной и не может быть общедоступна.

Детали инвестиционных условий предоставляются по запросу.



КОНТАКТЫ

ПЕТРУШИНА М.В.

+7 985 728 66 55
mar.petrushina@yandex.ru

© Петрушина М. В., 2026. Все права защищены. Конфиденциально. Копирование и распространение запрещено.